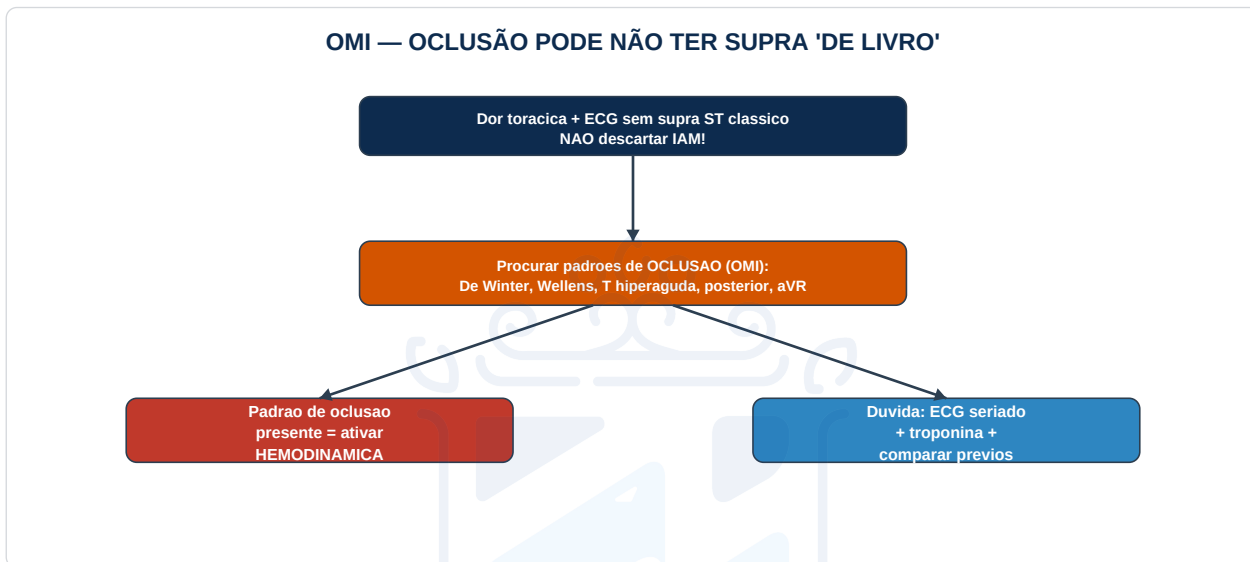


ECG — PADRÕES DE OCLUSÃO (OMI) E ALTO RISCO

FLUXOGRAMA — DOR TORÁCICA SEM SUPRA CLÁSSICO



CONCEITO FUNDAMENTAL — PARADIGMA OMI x STEMI

OCLUSÃO NÃO É SÓ 'SUPRA DE ST'

- OMI (Occlusion MI) = artéria ocluída que se beneficia de reperfusão IMEDIATA, mesmo SEM critério clássico de supra
- Cerca de 25-30% dos 'NSTEMI' têm artéria ocluída e pior prognóstico
- Reconhecer padrões de oclusão = ativar hemodinâmica como se fosse STEMI
- Sempre comparar com ECG prévio, repetir seriado e correlacionar com a clínica/troponina
- Na dúvida com instabilidade ou dor refratária: discutir cateterismo precoce

PADRÕES DE OCLUSÃO CORONARIANA (OMI)

Padrão	Achado no ECG	Significado
T hiperaguda	Ondas T amplas, simétricas, pontiagudas (precedem o supra)	Fase inicial de oclusão — vigiar
De Winter	Ponto J infra + ST ascendente + T altas/simétricas em V1-V6 (± supra aVR)	Oclusão proximal de DA
Wellens A	T bifásica (plus-minus) em V2-V3	Lesão crítica de DA proximal
Wellens B	T profundamente invertida e simétrica em V2-V3 (até V1-V6)	Lesão crítica de DA (75% dos casos)
Posterior	Infra ST V1-V3/V4; confirmar com V7-V8-V9 (supra em ≥1)	IAM infero-lateral/posterior
Aslanger	Supra em DIII isolado + ST V1>V2 + infra V4-V6	Oclusão inferior + doença multiarterial

PADRÕES DE ALTO RISCO / ARMADILHAS

Padrão	Achado no ECG	Significado
Isquemia circunferencial	Supra aVR ($\pm$ supra V1) + infra ST em >6 derivações	Lesão de tronco/DA proximal ou triarterial
'Bandeira da África do Sul'	Supra em DI, aVL e V2 ($\pm$ V1) + infra em DIII	Oclusão do 1o ramo diagonal (parede anterolateral alta)
Brugada (tipo 1)	Supra ST em cúpula ('barbatana de tubarão') + T invertida em V1-V3, QRS estreito	Canalopatia: risco de arritmia/morte súbita (NÃO é oclusão)

RED FLAGS — ATIVAR HEMODINÂMICA

OCCLUSÃO PROVÁVEL = REPERFUSÃO

- Qualquer padrão de OMI (De Winter, Wellens em evolução, T hiperaguda persistente, posterior confirmado)
- Supra de aVR com infra difuso + instabilidade -> suspeita de tronco: cateterismo urgente
- Dor torácica refratária a terapia, instabilidade hemodinâmica ou elétrica
- Sempre fazer derivações posteriores (V7-V9) e direitas (V3R-V4R) quando indicado
- Brugada tipo 1 com síncope/arritmia: monitorização + cardiologia (não é reperfusão)

DICAS PRÁTICAS DE AQUISIÇÃO

NÃO PERDER A OCLUSÃO

- Infra ST de V1 a V3 -> sempre solicitar V7, V8, V9 (posterior)
- Supra inferior -> avaliar V3R/V4R (acometimento de VD)
- ECG seriado a cada 10-15 min se dor persistente e ECG inicial duvidoso
- Wellens: padrão tipicamente aparece com o paciente SEM dor (período livre) — não subestimar
- Comparar SEMPRE com ECG prévio; correlacionar com curva de troponina

CONDUTA AO RECONHECER OMI

Rx PASSOS NO PS

1. Monitorização + acesso + O2 se SatO2 < 90% + desfibrilador à beira-leito
2. AAS 200-300 mg VO macerado
3. Acionar HEMODINÂMICA / discutir reperfusão como STEMI (não esperar troponina)
4. Anticoagulação e 2o antiagregante conforme protocolo local/estratégia de reperfusão
5. Nitrato e analgesia se dor (cautela: evitar nitrato em IAM de VD/hipotensão)
6. Se sem hemodinâmica no serviço: ativar transferência/regular para reperfusão

CHECKLIST DO ECG DE DOR TORÁCICA

ANTES DE 'DESCARTAR IAM'

- ☐ ECG em < 10 min da chegada e seriado se dor
- ☐ Procurei ativamente padrões de OMI (De Winter, Wellens, T hiperaguda, posterior, Aslanger)?
- ☐ Avaliei aVR (isquemia circunferencial) e fiz derivações posteriores se infra V1-V3?
- ☐ Comparei com ECG prévio e correlacionei com troponina/clínica?
- ☐ Padrão de oclusão presente -> hemodinâmica acionada / transferência regulada

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com dor torácica e ECG com padrão de OCLUSÃO: ____ (De Winter / Wellens / posterior / aVR+infra difuso).
- Sem supra clássico, mas padrão de OMI -> conduta de reperfusão. AAS administrado às ____.
- Troponina ____ | hemodinâmica local: disponível/indisponível.
- Solicito vaga em serviço com hemodinâmica para cateterismo/angioplastia primária URGENTE.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com dor torácica e ECG mostrando, em V1-V6, infradesnível do ponto J com ST ascendente e ondas T altas e simétricas. Qual o significado?

- A) Pericardite aguda
- B) Padrão de De Winter — equivalente de oclusão proximal da descendente anterior
- C) Repolarização precoce benigna
- D) Hipercalemia
- E) Bloqueio de ramo direito

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com angina recente, agora sem dor, e ECG com ondas T bifásicas/profundamente invertidas em V2-V3. Qual a conduta?

- A) Alta, pois está sem dor e sem supra de ST
- B) Reconhecer síndrome de Wellens (lesão crítica de DA) e encaminhar para estratégia invasiva — evitar teste ergométrico
- C) Iniciar AINE para pericardite
- D) Repetir ECG em 30 dias ambulatorialmente
- E) Tranquilizar: T invertida é sempre benigna

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Diante de infradesnível de ST de V1 a V3, qual conduta complementar é fundamental?

- A) Solicitar derivações posteriores V7, V8 e V9 para confirmar IAM posterior
- B) Solicitar apenas troponina e liberar
- C) Realizar massagem do seio carotídeo
- D) Administrar trombolítico imediatamente sem mais avaliação
- E) Solicitar derivações direitas V3R-V4R apenas

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

ECG com supradesnível em aVR associado a infradesnível de ST em mais de seis derivações, em paciente instável. Qual a interpretação?

- A) Isquemia circunferencial — sugere lesão de tronco da coronária esquerda ou doença triarterial
- B) Padrão normal
- C) Pericardite
- D) Síndrome de Brugada
- E) Bloqueio de ramo esquerdo isolado

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre o paradigma OMI (Occlusion MI) versus STEMI, é correto afirmar:

- A) Apenas o supra clássico de ST indica artéria ocluída
- B) Parte dos pacientes rotulados como NSTEMI tem artéria ocluída e se beneficia de reperfusão imediata
- C) Padrões como De Winter e Wellens não têm valor clínico
- D) Nunca se deve ativar hemodinâmica sem supra de ST clássico
- E) A troponina deve sempre preceder a decisão de reperfusão

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Infra do ponto J com ST ascendente e T altas/simétricas em precordiais é o padrão de De Winter, equivalente de oclusão proximal da DA — deve ser tratado como OMI (reperusão), mesmo sem supra clássico.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

T bifásica (tipo A) ou profundamente invertida (tipo B) em V2-V3, tipicamente no período sem dor, é a síndrome de Wellens — lesão crítica de DA. Indica-se estratégia invasiva; teste de esforço é perigoso (pode precipitar IAM).

QUESTÃO 3 → Resposta: A

Infra de ST em V1-V3 pode ser a imagem em espelho de um IAM posterior. As derivações posteriores V7-V8-V9 confirmam (supra em pelo menos uma), mudando a conduta para reperusão.

QUESTÃO 4 → Resposta: A

Supra de aVR ($\pm$ V1) com infra difuso em >6 derivações sugere isquemia circunferencial por lesão de tronco da coronária esquerda ou doença triarterial — alto risco, cateterismo urgente.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O paradigma OMI reconhece que ~25-30% dos NSTEMI têm artéria ocluída e pior prognóstico. Padrões como De Winter, Wellens, posterior e aVR identificam oclusão que se beneficia de reperusão imediata, mesmo sem supra clássico.

SM24
Suporte ao Plantão Médico